

NURS 280 — Human Sexual Health · Midterm Cram Sheet 期中速记表

UBC · Kristen Gilbert · Exam Tue June 2, 1–3pm · 中英对照高频考点;请与课堂笔记核对。

L1 · INTRO TO HUMAN SEXUALITY 第1讲 人类性学导论

WHO sexual health (2006) 世卫性健康(2006)

- Physical, emotional, mental & social well-being re: sexuality — **NOT merely absence of disease**; safe, pleasurable, rights respected.

与性相关的身体、情感、心理与社会的完好——不仅是没有疾病;安全、愉悦、权利受尊重。

Dailey's 5 Circles of Sexuality 戴利的性五环

- Sensuality** — pleasure through the senses (body image, response cycle, fantasy). 感官愉悦——通过感官体验快感(身体形象、性反应周期、幻想)。
- Intimacy** — emotional closeness: trust, caring, vulnerability. 亲密——情感亲近;信任、关怀、脆弱。
- Sexual Identity** — biological sex, gender identity/expression/role, orientation. 性身份——生理性别、性别认同/表达/角色、性取向。
- Sexual Health & Reproduction** — anatomy, intercourse, contraception, abortion, STIs. 性健康与生殖——解剖、性交、避孕、堕胎、性病。
- Sexualization** — the 'power' circle: using sex to influence/control (flirting → harassment, assault). 性化——“权力”环:用性影响/控制(调情→骚扰、性侵)。

L2 · THEORY & RESEARCH 第2讲 理论与研究

- Stayton** — 3 reasons sex is hard to discuss: **Ignorance, Secrecy, Trauma**. Stayton——性难以谈论的三因素:无知、保密、创伤。
- Kinsey** — first scientific study in N. America, **1940s**; **Kinsey Scale 0–6**. 金赛——北美最早科学研究,1940年代;金赛量表0–6。
- Masters & Johnson** — **1950s**; lab observation → the 4-phase response cycle. 马斯特斯与约翰逊——1950年代;实验室观察→四阶段性反应周期。

L3 · SEX EDUCATION IN CANADA 第3讲 加拿大性教育

- Education is a **provincial/territorial** responsibility; BC since **1995**; gatekeepers: boards, principals, parents, teachers. 教育属省/地区管辖;BC自1995年;把关者:教育局、校长、家长、教师。
- SIECCAN** 9 principles of comprehensive sex ed (accessible, rights-based, accurate, inclusive...).
- AOUM** (abstinence-only) ineffective; **Netherlands** = best outcomes. 仅婚前禁欲无效;荷兰=结果最好。

L4 · VALUES & BELIEFS 第4讲 价值观与信念

- Sources: **family, education, peers, media, faith, experience**. 来源:家庭、教育、同伴、媒体、信仰、经历。
- Schalet 'sleepover'**: ~9/10 US parents forbid vs ~9/10 Dutch parents permit a teen's partner overnight. Schalet “留宿”:约9/10美国父母禁止,约9/10荷兰父母允许青少年伴侣过夜。
- Teen pregnancy /1,000: **US 57 · Canada 28 · Netherlands 21**. 青少年怀孕(每千):美57·加28·荷21。

L5 · ANATOMY & PHYSIOLOGY 第5讲 解剖与生理

- Structures are **homologous** (clitoris↔penis); sex is **not strictly binary** (intersex is natural). 结构同源(阴蒂↔阴茎);性别非严格二元(间性自然)。
- SPERM**: seminiferous tubules → epididymis → vas deferens → ejac. duct (+seminal vesicle, prostate, Cowper's) → urethra. 精子:曲细精管→附睾→输精管→射精管(+精囊、前列腺、考珀氏腺)→尿道。
- EGG**: ovary → fimbriae → fallopian tube (**fertilization**) → uterus; else menstruation. 卵子:卵巢→伞端→输卵管(受精)→子宫;否则月经。
- Clitoris** largely internal, function = pleasure; 'hymen' → **vaginal corona**, not a virginity indicator. 阴蒂大部在体内,功能=快感;“处女膜”应称阴道冠,非处女标志。

L6 · AROUSAL PATTERNS 第6讲 性唤起模式

- M&J 4 phases**: Excitement → Plateau → Orgasm → Resolution; key process = vasocongestion. 四阶段:兴奋→平台→高潮→消退;核心=血管充血。
- Penis has a **refractory period**; the clitoris does **not**. 阴茎有不应期;阴蒂没有。
- Kaplan** added desire; **Basson** = responsive (intimacy-based) desire, circular model. 卡普兰加入欲望;巴森=反应性(基于亲密的)欲望,循环模型。
- Dual Control**: SES accelerator vs SIS brakes; **arousal nonconcordance** (response ≠ consent). 双重控制:SES油门 vs SIS刹车;唤起不一致(反应≠同意)。

L7 · CONCEPTION, PREGNANCY & BIRTH 第7讲 受孕、怀孕与分娩

- Conception **high in the fallopian tube**; egg viable ~24h, sperm 5–7 days; the **egg selects** the sperm; implantation ~2 wks = pregnant. 受精在输卵管上段;卵约24h,精子5–7天;卵子挑选精子;约2周着床=怀孕。

- 40–50%** of Canadian pregnancies unplanned; ~**15%** infertility (test after 1 yr; AB/SK no coverage). 40–50%计划外;约15%不孕(1年后检查;AB/SK不报销)。
- Miscarriage ~**1/3** (first 7 wks); **ectopic** = emergency. 流产约1/3(前7周);宫外孕=急症。
- Term 37 wk, post-dates 42**; labour: dilation → baby → placenta; **Apgar 1 & 5 min**. 足月37周,过期42;产程:扩张→胎儿→胎盘;Apgar 1和5分钟。

L8 · CONTRACEPTION 第8讲 避孕

- 4 mechanisms**: Hormonal (stop ovulation), Barrier, 'Natural', Emergency. 四机制:激素(抑制排卵)、屏障、自然、紧急。
- Hormonal: pill, patch, ring, injection, implant — all work the same; **free in BC**. 激素:药、贴片、环、注射、埋植——原理相同;BC免费。
- EC**: Plan B (delays ovulation; OTC), ella (Rx), **copper IUD = most effective** (≤7 days). 紧急:Plan B(延迟排卵;非处方)、ella(处方)、铜质节育器=最有效(≤7天)。
- IUDs are a barrier method** — most effective contraception, reversible. 宫内节育器是屏障法——最有效、可逆。

L9 · PREGNANCY OPTIONS 第9讲 怀孕的选择

- 3 options**: parent · adoption · abortion. 三选择:抚养·领养·堕胎。
- Adoption**: both birth parents consent (any age), day **10**, withdraw within **30 days**; records open at 19 (since 1996). 领养:双方亲生父母同意(不论年龄),第10天,30天内可撤;19岁公开(自1996)。
- R. v. Morgentaler (1988)** struck the abortion law (security of person, Charter s.7); **no law since**. R. v. Morgentaler(1988)废除堕胎法(人身安全权,宪章7条);此后无法。
- Procedural vs Medication** (Mifegymiso = mifepristone + misoprostol, <10 wk); **87%** in first 12 wk. 手术对比药物(Mifegymiso=米非司酮+米索前列醇,<10周);87%在前12周。

L10 · STIs — THE 'BIG EIGHT' 第10讲 性病——“八大”

- Bacterial (curable)**: Chlamydia · Gonorrhea · Syphilis · Pubic lice*. 细菌性(可治愈):衣原体·淋病·梅毒·阴虱*。
- Viral (manageable)**: Herpes · Hepatitis B · HIV · HPV (HPV & Hep B vaccine-preventable). 病毒性(可控):疱疹·乙肝·HIV·HPV(HPV和乙肝可疫苗预防)。
- Transmission**: fluids + skin-to-skin. 传播:体液+皮肤接触。
- Prevent**: barriers, vaccination, **PrEP** (HIV), testing, partner notification. 预防:屏障、疫苗、PrEP(HIV)、检测、伴侣告知。

SUPP · BASSON (2001) 补充 · 巴森(2001)

- Female desire is largely **responsive, not spontaneous**, intimacy-driven; the linear model is insufficient; drugs alone usually insufficient unless psychological factors are addressed. 女性欲望多为反应性而非自发,由亲密驱动;线性模型不足,除非处理心理因素,单用药物通常不足。

Outcomes by country 各国结果对比

Marker ■■	US ■	Can ■	Neth ■
Teen pregnancy* 青少年怀孕*	57	28	21
Sexual debut age 初次性行为年龄	16	17	17
3+ partners in HS 高中3+伴侣	19%	—	4%
'Love' = reason 1st sex “爱”为首次原因	59%	—	73%

*per 1,000 females 15–19. *每千名15–19岁女性。正常化→更低青少年怀孕。